

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA E CONSENSO TEST COMBINATO ALLARGATO PREECLAMPSIA

Informativa e consenso per il test combinato allargato
con valutazione del rischio di preeclampsia

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF068_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati della paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Settimana di gestazione	
Data esame	

1. Informativa sulla preeclampsia

La preeclampsia (PE), chiamata anche gestosi, è una complicanza della gravidanza caratterizzata da un aumento della pressione arteriosa materna associato a perdita significativa di proteine nelle urine, che insorge dopo la 20a settimana. Si riscontra in circa il 2-3% delle gravidanze e nei casi più gravi si possono avere importanti complicanze sia a carico della madre che del feto, come il ritardo della crescita fetale, il distacco di placenta e, nei casi estremi, convulsioni materne e morte intrauterina del feto.

2. Calcolo del rischio

Il calcolo del rischio di preeclampsia pretermine si può eseguire in associazione al test combinato, aggiungendo la valutazione della pressione arteriosa materna e la flussimetria delle arterie uterine (tecnica ecografica basata sull'effetto Doppler), oltre al dosaggio nel sangue materno della proteina plasmatica A (PAPP-A) ed eventualmente di una proteina chiamata fattore di crescita placentare PIGF.

3. Risultati e interpretazione

Lo screening viene considerato positivo quando il rischio calcolato per la preeclampsia pretermine è maggiore di 1:100. La positività non significa che la gestante andrà sicuramente incontro a preeclampsia, ma che presenta un rischio elevato; è pertanto opportuno eseguire controlli clinici ed ecografici più frequenti ed un eventuale trattamento precoce con aspirina a bassi dosaggi.

La negatività del test non significa che la gestante non andrà incontro alla preeclampsia, ma che presenta una bassa probabilità (circa lo 0,2%).

4. Trattamento preventivo

Nei casi positivi, l'assunzione di 150 mg di aspirina fino alla 35a settimana ha dimostrato di ridurre il rischio di sviluppare preeclampsia entro la 37a settimana di circa il 60%.

5. Espressione del consenso

Dichiaro di aver ben compreso i contenuti e le modalità dello screening della preeclampsia in associazione al test combinato.

Scelta	Barrare
Acconsento alla valutazione del rischio di preeclampsia pretermine, preferibilmente CON dosaggio PIGF (a 11 settimane)	☐
Non acconsento alla valutazione del rischio di preeclampsia pretermine	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		